

포텔리지오주20밀리그램(모가물리주맙)(한국교와기린(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1병 중 mogamulizumab 20mg
제형 및 성상	투명에서 유백광을 띄는 무색 용액이 무색 투명한 유리 바이알에 든 주사제
효능·효과	이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 균상식육종 또는 시자리증후군 성인 환자의 치료 1mg/kg으로 최소 60분 동안 정맥주사로 투여한다.
용법·용량	첫 주기(28일)에는 매 주에(1, 8, 15 및 22일) 투여하며, 이후 주기에 는 질병의 진행 또는 허용할 수 없는 독성이 나타나기 전까지 각 28일 주기의 2주 마다(1, 15일) 투여한다. 이 약은 예정일로부터 2일 이내에 투여해야 한다. 이 약의 투여가 2일 이상 늦어진 경우, 가능한 한 빨리 다음 용량을 투여해야 하며, 이후 새로운 투여일을 기준으로 투약 일정을 다시 계산해야 한다. 이 약을 처음 투여하는 경우, 해열제 및 항히스타민제의 사전 투약이 권장된다. 주입 관련 반응이 발생하는 경우, 이 약을 다음 투여할 때도 사전 투약을 실시한다.
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품
품목허가일	2022년 9월 22일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

- 균상식육종(Mycosis fungoides, MF) 및 시자리증후군(SS, Sézary syndrome)
 - 균상식육종은 피부 T세포 림프종(CTCL, Cutaneous T-cell Lymphoma)의 대표적인 질환으로 말초 T 림프구에서 종양이 발생하므로 피부의 어느 곳이나 발생할 수 있으며, 피부 이외에도 림프절, 혈액 및 내부 장기로 퍼질 수 있음.
 - 시자리증후군은 피부 T세포 림프종의 드문 백혈화 유형으로 약 5% 미만을 차지하며, 전신성 홍피증과 순환 종양 세포가 발생할 수 있음. 홍피증을 유발하는 비정형 T세포인 시자리세포와 세포병리학적 평가에 의해 시자리 세포로 정의되는 비정상 T세포(>1,000 비정상 세포/ μ L)의 상당한 혈액 관련이 특징임.
- (증상 및 예후) 일반적으로 다양한 모양의 반이 발생해 수년간 지속되다가 악성세포가 증식하면서 병변이 단단해지고 여러 모양의 판, 결절, 홍피증이나 종양으로 진행됨. 피부, 림프절 및 내부 장기 침범 정도에 따라 예후가 달라지며, 일반적으로 병변의 범위가 적을수록 예후가 좋음. 대부분의 환자는 피부병변 이외의 이상을 보이지 않지만 10~20%의 환자에서 림프절이나 폐, 비장, 간 등의 내부 장기를 침범하며, 내부 장기 침범 시 생존 기간은 수개월임.
- (병기) 병변의 양상, 피부에 퍼진 정도, 내부 장기 침범여부, 혈액 속에 피부 림프종의 출현 여부 등을 기준으로 하여 병기를 결정함.

1) 국가암정보센터(<https://cancer.go.kr/>)

2) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

3) Williams Hematology. 10e. 2021

4) NCCN Guidelines Primary Cutaneous Lymphomas. Version 1. 2023

Clinical Staging of MF and SS ^a					
Clinical Stage ^a	T (Skin)	N (Node)	M (Visceral)	B (Blood Involvement)	Guidelines Page
IA (Limited skin involvement)	T1 (Patches, papules, and/or plaques covering <10% body surface area [BSA])	N0	M0	B0 or B1	MFSS-6
IB (Skin only disease)	T2 (Patches, papules, and/or plaques covering ≥10% BSA)	N0	M0	B0 or B1	MFSS-7
IIA	T1-2	N1-2	M0	B0 or B1	MFSS-7
IIB (Tumor stage disease)	T3 (One or more tumors [≥1 cm in diameter])	N0-2	M0	B0 or B1	MFSS-8
IIIA (Erythrodermic disease)	T4 (Confluence of erythema ≥80% BSA)	N0-2	M0	B0	MFSS-10
IIIB (Erythrodermic disease)	T4 (Confluence of erythema ≥80% BSA)	N0-2	M0	B1	MFSS-10
IVA ₁ (Sézary syndrome)	T1-4	N0-2	M0	B2	MFSS-11
IVA ₂ (Sézary syndrome or Non-Sézary)	T1-4	N3	M0	B0 or B1 or B2	MFSS-11
IVB (Visceral disease)	T1-4	N0-3	M1	B0 or B1 or B2	MFSS-11
	Large-cell transformation (LCT) ^{aa}				MFSS-12

- (치료) 일반적으로 국소 병변인 경우에는 국소 치료를 하며, 전신적으로 병변이 존재할 경우(병변 부위가 넓거나, 홍피증 등을 보이는 경우) 전신 치료를 시행함. 치료로는 니트로겐 머스타드(Nitrogen mustard) 국소 도포 요법, 전자속(electron beam)요법, 광화학요법(PUVA), 전신항암화학요법, 스테로이드의 국소 및 전신요법, 인터페론 요법, 레티노이드 요법 등이 있으며 이것을 단독 혹은 병행하여 치료함.

(2) 약제 특성⁵⁾

- 신청품은 "이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 군상식육종 또는 시자리증후군 성인 환자의 치료"에 허가된 약제임.
- 신청품은 C-C 케모카인의 G 단백질 결합 수용체인 케모카인(C-C 모티프) 수용체 4(chemokine receptor 4, CCR4)에 선택적으로 결합하는 탈푸코실화된(defucosylated) 인간화 면역글로불린 G 아형 1(IgG1) 카파 단일클론항체임.
 - CCR4 발현 표적 세포에 대해 기존의 푸코실화된 항체보다 더 큰 항체의존성 세포독성(antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC)을 일으켜 항종양 활성을 유도함.

5) 신청품의 의약품 품목허가 보고서

(3) 교과서⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ 및 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾

- 신청품은 교과서에서 균상식육종 또는 시자리증후군의 전신 치료에 사용하는 단일클론 항체로 소개되고 있으며, 임상진료지침에서 하나 이상의 치료에 실패한 경우 권고되고 있음.
- NCCN guidelines Primary Cutaneous Lymphomas version 1.2023¹³⁾
 - 균상식육종 및 시자리증후군에 각 병기별로 권고되고 있음(preferred, category 2A)

병기	IB ~ IIA		IIB	III
권고 수준	MF		MF	MF (Erythrodermic disease)
선호 요법	- Bexarotene - Brentuximab vedotin - Interferon alfa - Methotrexate Mogamulizumab - Romidepsin - Vorinostat		- Bexarotene - Brentuximab vedotin - Gemcitabine* - Interferon alfa - Liposomal doxorubicin* - Methotrexate Mogamulizumab - Pralatrexate* - Romidepsin	- Bexarotene - Brentuximab vedotin - Interferon alfa - Methotrexate Mogamulizumab - Romidepsin - ECP
기타 요법	-		- Vorinostat - Pembrolizumab (category 2B)	Vorinostat
병기	IV			
권고 수준	SÉZARY SYNDROME (IVA1 or IVA2)		Non-Sézary(IVA2) or Visceral/Solid Organ(IVB) Disease	
	경증~중등증(ASC>5K/mm ²)	중증(ASC>5K/mm ²)		
선호 요법	- Bexarotene - ECP - Interferon alfa - Methotrexate Mogamulizumab - Romidepsin - Vorinostat	Mogamulizumab - Romidepsin	- Brentuximab vedotin - Gemcitabine - Liposomal doxorubicin - Pralatrexate - Romidepsin	
기타 요법	- Alemtuzumab - Brentuximab vedotin - Gemcitabine	- Alemtuzumab - Bexarotene - Brentuximab vedotin	- Mogamulizumab - Multi-agent chemotherapy regimens	

6) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

7) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer. 12e. 2022

8) The MD Anderson Manual of Medical Oncology. 4e. 2022

9) Williams Hematology. 10e. 2021

10) Skin Lymphoma: The Illustrated Guide. 5th. 2020

11) NCCN Guidelines Primary Cutaneous Lymphomas. Version 1. 2023

12) Latzka J et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome – Update 2023. Eur J Cancer. 2023;195:113343

13) NCCN Guidelines Primary Cutaneous Lymphomas. Version 1. 2023

• Liposomal doxorubicin • Pembrolizumab • Pralatrexate	• ECP • Gemcitabine • Interferon alfa • Liposomal doxorubicin • Methotrexate • Pembrolizumab • Pralatrexate • Vorinostat	
--	---	--

* Generalized tumor disease인 경우에만 해당
복합요법이나 특정 상황에서 권고되는 경우는 따로 기술하지 않음

○ EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sezary syndrome¹⁴⁾

– 균상식육종 및 시자리증후군의 각 병기에서 전신 요법으로 1차 또는 2차 치료로 권고되고 있음(level 2).

병기	1차 치료		2차 치료	
MF IA, IB, IIA	Expectant policy (mainly T1a) SDT – Topical corticosteroids – Topical chlormethine – nbUVB – PUVA – Localised RT	level 4 level 3 level 2 level 2 level 2 level 4	Systemic therapies – Retinoids – IFN-α TSEB (mainly T2b) Brentuximab vedotin Mogamulizumab Low-dose MTX	 level 2 level 2 level 2 level 2 level 2 level 2
MF IIB	Systemic therapies – Retinoids – IFN-α TSEB Brentuximab vedotin Mogamulizumab Monochemotherapy (Pegylated liposomal doxorubicin, gemcitabine) Low-dose MTX Localised RT	 level 2 level 2 level 2 level 2 level 2 level 4 level 4 level 4	(Poly-)chemotherapy Brentuximab vedotin Mogamulizumab Allogeneic stem cell transplant	 level 3 level 2 level 2 level 2
MF IIIA-III B	Systemic therapies – Retinoids – IFN-α ECP Brentuximab vedotin Mogamulizumab Low-dose MTX TSEB	 level 2 level 2 level 3 level 2 level 2 level 4 level 2	Monochemotherapy (gemcitabine, pegylated liposomal doxorubicine) Brentuximab vedotin Mogamulizumab Allogeneic stem cell transplant	 level 3 level 2 level 2 level 2
MF IVA-IV B	Chemotherapy (gemcitabine, pegylated liposomal doxorubicine, CHOP and CHOP-like polychemotherapy)			level 3

14) Latzka J et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sezary syndrome – Update 2023. Eur J Cancer. 2023;195:113343

	Radiotherapy (TSEB/localised)			level 4
	Brentuximab vedotin			level 2
	Mogamulizumab			level 2
	Alemtuzumab (mainly in B2)			level 3
	Allogeneic stem cell transplant			level 2
SS	ECP	level 3	Mogamulizumab	level 2
	Systemic therapies in combination with ECP or PUVA		Brentuximab vedotin	level 2
	– Retinoids	level 3	Alemtuzumab	level 3
	– IFN-α	level 3	Chemotherapy (gemcitabine, pegylated liposomal doxorubicine, CHOP and CHOP-like polychemotherapy)	level 3
	Chlorambucil+prednisone	level 3		
	Low-dose MTX	level 4	Allogeneic stem cell transplant	level 2

(4) 임상 시험 결과

- [MAVORIC]¹⁵⁾ 18세 이상의 재발 또는 불응성 균상식육종 또는 시자리 증후군 환자¹⁶⁾(n=372)를 대상으로 신청품과 vorinostat¹⁷⁾의 유효성과 안전성 비교를 위한 무작위, 공개, 다국가, 3상 시험을 시행한 결과,
 - 1차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival)의 중앙값은 신청품군에서 7.7개월(95% CI 5.7-10.3), vorinostat군에서 3.1개월(95% CI 2.9-4.1)로 신청품군에서 유의하게 개선됨(HR 0.53, 95% CI 0.41-0.69, $p<0.0001$)¹⁸⁾.

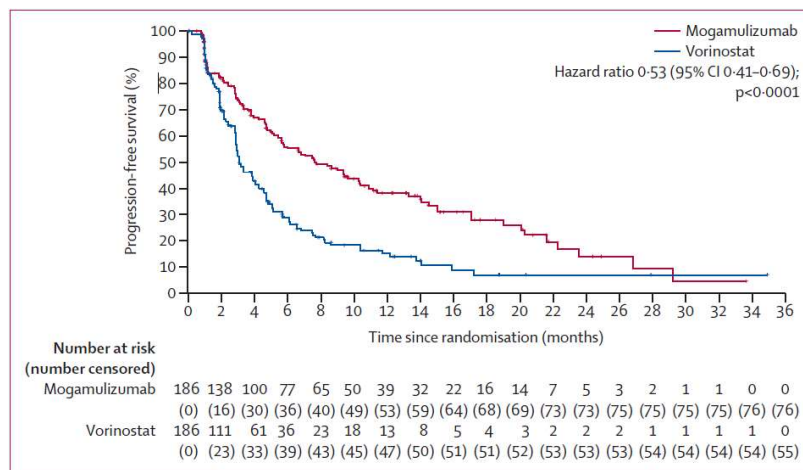


Figure 2: Progression-free survival by investigator assessment

- 사전에 정의된 하위군에 따른 무진행생존기간의 위험비는,
 - ✓ 균상식육종의 경우 0.72(95% CI 0.51-1.01), 시자리증후군은 0.32(95% CI 0.21-0.49)로 균상식육종보다 시자리증후군에서 vorinostat 대비 더 큰 개선을 보임.
 - ✓ 병기 IB/II의 경우 0.88(95% CI 0.58-1.35), 병기 III/IV의 경우

15) Kim YH et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(9):1192-1204.

16) Stage IB~IVB로, 이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 환자를 대상으로 함.

	Mogamulizumab (n=186)	Vorinostat (n=186)
Diseas type		
Mycosis Fungoides	105 (56%)	99 (53%)
Sezary syndrome	81 (44%)	87 (47%)
Current clinical stage		
IB-IIA	36 (19%)	49 (26%)
IIB	32 (17%)	23 (12%)
IIIA-IIIB	22 (12%)	16 (9%)
IVA1	73 (39%)	82 (44%)
IVA2	19 (10%)	12 (6%)
IVB	4 (2%)	4 (2%)

17) 졸린자캡슐, 미등재 약제로 품목허가 유효기간 만료됨('23.7.1.).

18) 독립적 검토 시 신청품군에서 6.7개월(95% CI 5.6-9.4), vorinostat군에서 3.8개월(95% CI 3.0-4.7)로 신청품군에서 유의하게 개선됨(HR 0.64, 95% CI 0.49-0.84, $p<0.0007$).

0.36(95% CI 0.26–0.51)로 III/IV에서 더 큰 개선을 보임.

- 2차 평가지표인 전반적 반응률(ORR, overall response rate)은 신청품군에서 28%(52/186명, 95% CI 21.6–35.0), vorinostat군에서 5%(9/186명, 95% CI 2.2–9.0)으로 신청품군에서 유의하게 높았음(RR 23.1, 95% CI 12.8–33.1, $p<0.0001$)¹⁹⁾.

▪ 사전에 정의된 하위군에 따른 전반적 반응률은,

- ✓ 균상식육종의 경우 신청품군 21%(22/105명), vorinostat군에서 7%(7/99명), 시자리증후군의 경우 신청품군 37%(30/81명), vorinostat군 2%(2/87명)이었음.
- ✓ 모든 병기에서 신청품의 전반적 반응률이 높았음.

Overall responses	Mogamulizumab (n=186)	Vorinostat (n=186)
Stage IB or IIA	7/36 (19%)	5/49 (10%)
Stage IIB	5/32 (16%)	1/23 (4%)
Stage III	5/22 (23%)	0/16 (0%)
Stage IV	35/96 (36%)	3/98 (3%)

- 안전성 평가결과, 치료와 관련된 중대한 이상반응은 신청품군에서 20%(36/184명), vorinostat군에서 16%(30/186명)으로 보고되었으며, 가장 많이 보고된 치료 관련 중대한 이상반응은 신청품군에서 폐렴(2%, 4명), 발열(2%, 4명), vorinostat군에서 폐색전증(3%, 5명), 혈소판감소증(2%, 3명)이었음.

○ [OMEGA, RWE]²⁰⁾ 최소 한 번 이상 신청품을 투여받은 균상식육종 또는 시자리증후군 성인 환자(n=122)²¹⁾²²⁾를 대상으로 신청품의 유효성 및 내약성을 평가한 다기관, 후향적 관찰 연구 결과,

- 1차 평가변수인 전반적 반응률(ORR, overall response rate)²³⁾은 58.7%(95% CI 48.9–68.1)로 관찰되었으며, 균상식육종 환자(69.5%, 95% CI 56.1–80.8)에서보다 시자리증후군 환자(46.0%, 95% CI 31.8–60.7)에서 더 높은 반응률이 관찰됨.

19) 독립적 검토 시 신청품군에서 23%(43/186명, 95% CI 17.3–29.8), vorinostat군에서 4%(7/186명, 95% CI 1.5–7.6)으로 신청품군에서 유의하게 높았음(RR 19.4, 95% CI 9.0–29.4, $p<0.0001$).

20) Beylot-Barry M et al. Impact of blood involvement on efficacy and time to response with mogamulizumab in mycosis fungoides and Sézary syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(2):311–316.

21) 유효성 평가군 122명(균상식육종 53명, 시자리증후군 69명) 중 평가 가능한 환자는 109명(균상식육종 50명, 시자리증후군 59명)이었음.

22) 프랑스 14개 기관에서 2020년 3월까지 균상식육종 또는 시자리증후군 환자에서 신청품을 1회 이상 투여받은 성인 환자에 대한 후향적 데이터를 수집함.

23) 신청품 치료 후 CR(complete response) 또는 PR(partial response)을 나타낸 환자의 비율

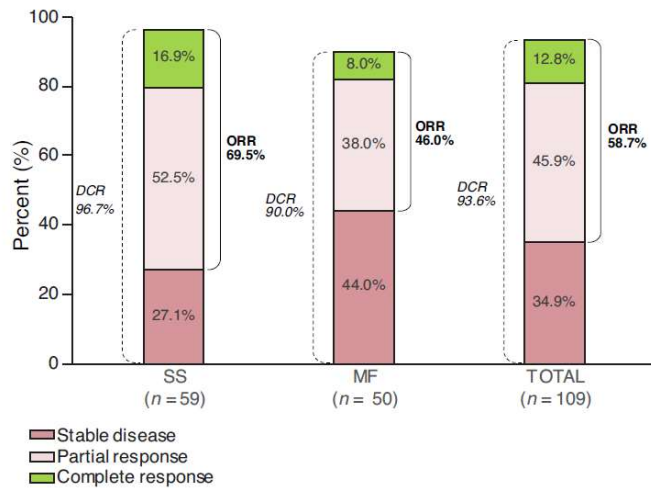


FIGURE 1 Overall response rate and disease control rate under mogamulizumab treatment. DCR, disease control rate; MF, Mycosis Fungoides; ORR, overall response rate; SS, Sézary syndrome.

- 관련 구획별 반응률의 경우, 혈액 반응은 시자리증후군 환자에서 81.8%(45/55명), 피부 반응은 시자리증후군에서 66.7%(38/61명, 군상 식육종에서 46.0%(23/50명)로 관찰됨.

표. 구획별 반응률

Compartment	SS (n=59)	MF (n=50)	Total (n=109)
Blood	45/55 (81.8%) [69.1–90.9]	NA	NA
Skin	38/57 (66.7%) [52.9–78.6]	23/50 (46.0%) [31.8–60.7]	51/107 (57.0%) [47.1–66.5]
Lymph nodes	9/15 (60.0%) [32.3–83.7]	5/19 (26.3%) [9.1–51.2]	14/34 (41.2%) [24.6–59.3]
Viscera	0/2 (0.0%) NA	2/8 (25.0%) [3.2–65.1]	2/10 (20.0%) [2.5–55.6]

n/N(%), [95% CI]

- 전반적 반응률은 혈액 침범²⁴⁾이 있는 환자에서 유의하게 높았음 (p=0.0030). B0(MF 환자)는 46.8%의 반응률을 보인것에 비해, B1(MF 환자)는 75.0%, B2(SS 환자)는 69.5%의 반응률을 보임.

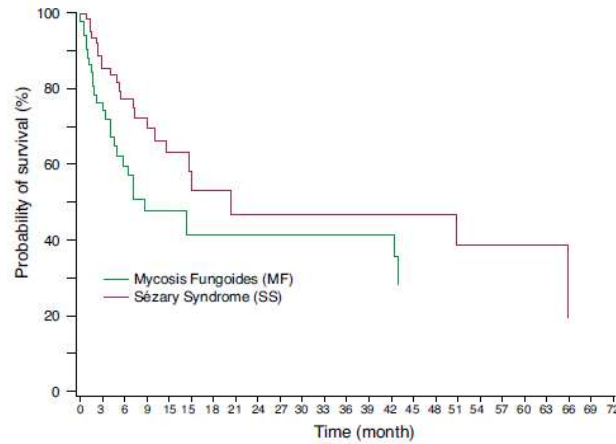
표. 기저치에서 혈액 침범 상태에 따른 전반적 반응률

Blood involvement at baseline	B0 (n=38)	B1 (n=12)	B2 (n=59)
ORR	14 (36.8%)	9 (75.0%)	41 (69.5%)
CR	0 (0.0%)	4 (33.3%)	10 (16.9%)
PR	14 (36.8%)	5 (41.7%)	31 (52.5%)

n(%)

24) 혈액 침범은 혈액 내 면역표현형적으로 비정상적인 T 세포의 수를 기준으로 B0, B1, B2 세 그룹으로 분류됨. B1 또는 B2는 유세포 분석 및 T세포 수용체 유전자 재배열 분석을 통해 피부에서와 같이 클론 관련 종양성 T세포의 존재로 가장 잘 특징지어짐. 시자리증후군의 진단에는 B2 수준의 혈액 침범이 필요함.

- 무진행생존기간 중앙값은 15.0개월로 추정되었으며(95% CI 9.0-50.8), 균상식육종 환자(8.8개월, 95% CI 4.6-43.0)보다 시자리증후군 환자(20.3개월, 11.7-NR)에서 더 길었지만, 유의한 차이를 보이지 않음($p=0.0542$).



- 안전성 평가군 124명의 환자의 56.5%(70명)에서 적어도 하나의 치료 관련 이상반응이 보고되었으며, 가장 흔한 이상반응은 림프구감소증(23.4%), 무력증(17.7%), 발진(14.5%), 주입관련반응(12.1%)으로 보고됨.

(5) 학회 의견

- 관련 학회²⁵⁾에 따르면, 균상식육종 및 시자리증후군의 치료제가 제한적인 상황에서 보통 광선치료, 방사선치료 및 경구 MTX를 사용하지만 효과가 크지 않고, 2차 치료로 brentuximab을 사용 가능하나 CD30 양성인 경우에만 급여가 인정되고 있으며 치료기간이 제한적이므로 CD30 상태와 무관하게 대상 질환에 대해 사용할 수 있는 약제가 필요한 상황임. 신청품은 임상시험을 통해 CD30 양성 여부와 상관없이 효과를 입증하였고, 예후가 좋지 않은 시자리증후군 환자에서도 효과를 입증한 유일한 약제로, 균상식육종 및 시자리증후군 환자들에게 brentuximab 외에 추가로 사용할 수 있는 치료적 선택지가 될 수 있을 것이라는 의견임.

25) 대한항암요법연구회(), 대한혈액학회(), 대한중양내과학회(), 대한피부과학회(), 대한항암요법연구회(), 대한피부과학회(), 대한중양내과학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 균상식육종 또는 시자리증후군 성인 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, brentuximab vedotin이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 제162차 암질환심의위원회, 2023년 10월 11일

28. 비호지킨림프종(Non-Hodgkin's lymphoma) [2군 항암제를 포함한 요법]			
연번	항암요법	투여대상	투여단계
20	mogamulizumab	이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 병기 IIB 이상의 균상식육종(mycosis fungoides) 또는 시자리증후군(Sezary Syndrome) 성인 환자 ※ large cell transformation 제외	2차 이상

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과
 - NICE(2021.12.): 권고, commercial arrangement
 - 신청품은 최소 1회 이상 전신 치료를 받은 성인 시자리증후군 환자에서 회사가 commercial arrangement에 따라 신청품을 공급할 경우 권고됨
 - 신청품은 성인 균상식육종 환자에서 다음 경우에 권고됨.
 - ✓ 병기 IIB 이상 및
 - ✓ 최소 2회 이상 전신 치료를 받은 경우 및
 - ✓ 회사가 commercial arrangement에 따라 신청품을 공급할 경우
 - 신청품은 1회 이상 전신치료를 받은 성인 균상식육종 및 시자리증후군 환자의 치료에 허가됨. 회사는 시자리증후군에서 1회 이상 전신치료를

받은 군에 대해 설정하였지만 군상식육종에서는 2회 이상 전신치료를 받은 군에 대해서만 설정하였으며, 이는 이 집단에 치료 옵션이 제한되어 있기 때문임.

- 신청품은 영국에서 사용할 수 없는 vorinostat와 직접 비교한 결과뿐이며, NHS 표준 치료와 직접 비교되지 않았음. NHS 표준 치료와 간접 비교 시 더 오래 살 가능성이 있음을 알 수 있음. 임상 성과에 영향을 미치는 다양한 요인을 모두 고려하지 않았기 때문에 간접 비교의 근거는 불확실하며, 근거가 추가되어 불확실성이 개선될 가능성은 낮음.

– SMC(2021.6.): 제한된 권고, PAS, simple discount

- 검토 적응증: 최소 1회 이상 전신 치료를 받은 성인 군상식육종(MF) 또는 시자리증후군(SS) 환자의 치료
- SMC 제한: 이전에 최소 1회 이상 전신치료를 받은 진행성 MF 또는 SS($\geq$ IIB MF 및 모든 SS) 환자에서 brentuximab vedotin 치료에 임상적으로 적합하지 않거나 불응성인 경우
- 신청품의 공개 3상 연구에서 HDAC(histone deacetylase) 억제제와 비교하여 무진행생존기간의 유의한 개선과 관련이 있었음.
- 이 권고는 PAS(patient access scheme) 가격과 같거나 더 낮은 가격에서만 적용됨.

– PBAC(2020.11.): 권고하지 않음

- PBAC은 재발성 또는 불응성 피부 T세포 림프종(CTCL) 환자의 치료에 mogamulizumab을 권고하지 않음.
- PBAC은 경제성 분석의 기반이 되는 결과인 전반적 반응률이 임상시험 전반에 걸쳐 가변적이며, 최종 환자 결과에 불확실한 영향을 미치는 것으로 간주함. 또한 ORR당 비용 증분이 수용할 수 없을 정도로 높고 불확실하므로 제안된 가격에서 비용효과적이지 않다고 판단함.
- PBAC은 vorinostat을 주 비교약제로, brentuximab vedotin을 2차 비교약제로 선택한 것을 수용하였음을 상기시켰으며(2020년 7월 PBAC 회의), 재제출 시 2차 비교약제와 관련하여 공식적인 제출이 없었다는 점을 언급함.

– CADTH(2022.8.): 조건부 권고

- 이전에 최소 1회 전신 치료를 받은 재발성 또는 불응성 성인 군상식육종 또는 시자리증후군 환자에 권고함. 환자의 건강상태는 상대적으로 양호해야함.
- 전문가가 처방해야 하며, 최소 51% 이상의 가격인하 시 급여됨.